

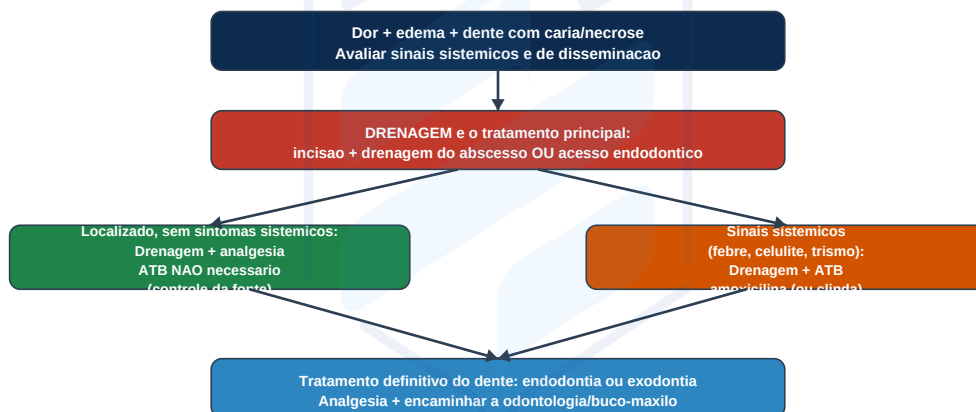
ABSCESSO DENTAL — DRENAR + ATB SE SISTÊMICO

TIPOS DE ABSCESSO ODONTOGÊNICO

Tipo	Origem	Características
Periapical (dentoalveolar)	Necrose pulpar (cárie profunda)	Dor à percussão, edema localizado, dente desvitalizado
Periodontal	Bolsa periodontal profunda	Dente vital, edema gengival lateral, mobilidade dental
Pericoronário (pericoronarite)	Terceiro molar semi-incluso	Edema retromolar, trismo, mau hálito
Abscesso de espaço fascial	Disseminação do abscesso primário	Edema de face/pescoço — risco de via aérea

MANEJO DO ABSCESSO DENTOALVEOLAR

ABSCESSO DENTAL — DRENAGEM É O TRATAMENTO



SINAIS DE GRAVIDADE — DISSEMINAÇÃO FASCIAL

QUANDO O ABSCESSO DENTAL VIRA EMERGÊNCIA

- Angina de Ludwig: celulite bilateral de assoalho de boca → elevação da língua → obstrução de via aérea
- Trismo importante: dificuldade de abrir a boca (espaço mastigatório)
- Disfagia, sialorreia, voz abafada: comprometimento de espaços profundos do pescoço
- Edema periorbitário/proptose: disseminação para seio cavernoso (trombose) — risco de morte
- Febre alta + toxemia + taquicardia: sepse odontogênica
- Conduta: internação + ATB IV + drenagem cirúrgica + proteção de via aérea + TC cervical

ANTIBIOTICOTERAPIA — QUANDO E QUAL

Situação	Antibiótico	Observações
Abscesso localizado drenado, sem sistêmico	NENHUM (apenas drenagem)	ATB não substitui a drenagem; uso desnecessário gera resistência
Com sinais sistêmicos / celulite	Amoxicilina 500 mg 8/8h VO 7d	1a linha; cobre flora oral (estrepto + anaeróbios)
Alergia à penicilina	Clindamicina 300 mg 6/6h VO	Boa penetração óssea; cobre anaeróbios
Refratário / grave	Amoxicilina-clavulanato ou ampicilina-sulbactam IV	Internação; cobertura ampliada
Sepse / espaço fascial profundo	Ampicilina-sulbactam IV + drenagem	Internação + buco-maxilo + via aérea

DOR DENTAL NO PS — MANEJO TEMPORÁRIO

Analgesia

- AINE: ibuprofeno 600 mg 8/8h (melhor que paracetamol na dor dental)
- Associação: ibuprofeno + paracetamol (sinergia, mais eficaz que opioide)
- Dipirona 1 g 6/6h como alternativa
- Opiode: reservar para dor intensa refratária (codeína)
- Bloqueio anestésico local: alívio temporário de dor intensa no PS
- Compressas: frias na fase aguda, evitar calor (acelera disseminação)

Orientações de Alta

- Encaminhar à odontologia para tratamento definitivo (endo ou exodontia)
- Higiene oral, bochechos com clorexidina 0,12%
- Retornar se: febre, edema progressivo, dificuldade de engolir/respirar, trismo
- Não usar antibiótico sem drenagem como tratamento isolado
- Concluir o ciclo de ATB se prescrito
- Controle de fatores: diabetes, imunossupressão (pior evolução)

ABORDAGEM NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Drenagem é o tratamento principal — antibiótico é adjuvante, não substitui
- ☐ ATB indicado apenas se: sinais sistêmicos, celulite, imunossupressão ou disseminação fascial
- ☐ Avaliar via aérea: trismo, disfagia, elevação de língua = emergência (angina de Ludwig)
- ☐ Amoxicilina é 1a linha; clindamicina se alergia à penicilina
- ☐ TC cervical com contraste se suspeita de espaço fascial profundo
- ☐ Encaminhamento odontológico obrigatório para tratamento definitivo do dente

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com abscesso periapical localizado, sem febre, sem celulite, em bom estado geral. Qual é o tratamento principal?

- A) Antibiótico oral isolado por 7 dias
- B) Drenagem do abscesso (incisão ou acesso endodôntico) + analgesia; ATB não é necessário
- C) Apenas analgésico e observação
- D) Antibiótico intravenoso e internação
- E) Corticoide oral para reduzir inflamação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com abscesso dentário e edema bilateral de assoalho de boca, elevação da língua e dificuldade respiratória. Qual é a complicação e a conduta?

- A) Pericoronarite — bochecho com clorexidina
- B) Angina de Ludwig — emergência: internação, ATB IV, drenagem e proteção de via aérea
- C) Abscesso periodontal simples — drenagem ambulatorial
- D) Sinusite maxilar — descongestionante
- E) Cárie profunda — endodontia eletiva

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o antibiótico de primeira linha para abscesso dentoalveolar com sinais sistêmicos em paciente SEM alergias?

- A) Ciprofloxacino 500 mg 12/12h
- B) Amoxicilina 500 mg 8/8h
- C) Azitromicina 500 mg/dia
- D) Vancomicina IV
- E) Metronidazol isolado

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente alérgico à penicilina com abscesso dentário e celulite facial. Qual antibiótico é mais adequado?

- A) Amoxicilina-clavulanato
- B) Ampicilina
- C) Clindamicina 300 mg 6/6h
- D) Cefalexina
- E) Penicilina V oral

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que o antibiótico isolado, sem drenagem, é uma conduta inadequada no abscesso dentoalveolar?

- A) Porque os antibióticos não atingem a cavidade oral
- B) Porque o controle da fonte (drenagem da coleção purulenta) é essencial — o ATB sozinho não resolve a coleção e favorece resistência
- C) Porque o abscesso dentário nunca precisa de antibiótico
- D) Porque a drenagem é mais barata
- E) Porque os antibióticos pioram a dor dental

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Abscesso periapical localizado sem repercussão sistêmica: drenagem (incisão e drenagem ou acesso endodôntico) é o tratamento principal — controle da fonte. Antibiótico NÃO é necessário nesses casos (sem febre, sem celulite). Analgesia + encaminhamento odontológico para tratamento definitivo.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Angina de Ludwig: celulite bilateral dos espaços submandibular, sublingual e submentual → elevação e deslocamento posterior da língua → obstrução de via aérea. Emergência: internação, ATB IV (ampicilina-sulbactam), drenagem cirúrgica e proteção de via aérea (IOT precoce ou traqueostomia).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Amoxicilina 500 mg 8/8h é a 1ª linha para abscesso dentário com sinais sistêmicos — cobre a flora oral (estreptococos e anaeróbios). Sempre associada à drenagem. Em casos refratários: amoxicilina-clavulanato. ATB nunca substitui o controle da fonte.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Clindamicina 300 mg 6/6h é a escolha em alérgicos à penicilina — boa penetração óssea e cobertura de anaeróbios da flora oral. Cefalexina e amoxicilina-clavulanato devem ser evitadas pela reatividade cruzada/penicilina. Sempre associar à drenagem.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O controle da fonte (drenagem da coleção purulenta) é o pilar do tratamento de qualquer abscesso. O antibiótico isolado não penetra adequadamente na coleção avascular, não resolve o foco e seleciona resistência. Drenagem + tratamento definitivo do dente são essenciais.

SM24
Suporte ao Plantão Médico